PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

Autos n.º	**0713789-81.2024.8.01.0001**
Classe	**Procedimento Comum Cível**
Autor	**Maria Fátima Ribeiro Teixeira**
Réu	**UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA**

Sentença

Maria Fátima Ribeiro Teixeira ajuizou ação contra **UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.**

A demandante afirma ser beneficiária do plano de saúde/réu, contando, à época do ajuizamento da ação, com 63 anos. Afirma que no ano de 2016 foi diagnosticada com **Artrite Reumatóide – CID 10 M05.3**, situação esta que causava-lhe intensas dores articulares. Afirma que tentou diversos medicamentos, mas que apenas com o medicamento Rinvoq 15mg (princípio ativo Upadacitinibe) conseguiu ter uma melhora substancial, não podendo ficar sem o fármaco.

Informa que a demandada passou a fornecer o medicamento a partir de 18/10/2021, sendo esta fornecida para o prazo de três meses, de forma ininterrupta, mas que de forma arbitrária foi comunicada da negativa do plano de saúde de continuidade de fornecimento do medicamento, por ser medicamento para tratamento domiciliar.

Afirma ainda que o medicamento era de difícil aquisição, e ficou um período sem ele, tendo conseguido comprar em uma farmácia no interior de Goiás, por R$ 7.198,03 (sete mil, cento e noventa e oito reais e três centavos).

Juntou aos autos os documentos de págs. 24/104.

Diante da negativa no fornecimento do medicamento, do seu alto custo, entendeu necessário o ajuizamento da presente ação. Requereu o fornecimento do medicamento em sede de tutela provisória de urgência, e no mérito a confirmação da liminar, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Unimed apresentou manifestação prévia (págs. 105/114), juntando documentos.

Decisão interlocutória indeferindo a tutela de urgência, recebendo a inicial, e determinando a citação da parte ré (págs. 169/172).

Contestação apresentada pela Unimed (págs. 184/198), onde no mérito requereu o julgamento improcedente dos pedidos iniciais sob os seguintes argumentos: A)

Endereço: Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8452, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv5rb@tjac.jus.br - Mod. 500076 - Autos n.º 0713789-81.2024.8.01.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.

Exclusão de cobertura assistencial para fornecimento de medicamento oral para uso domiciliar – Tratamento não oncológico 0 Informativo 694 do STJ. B) O medicamento oral, além d enão ser utilizado para tratamento oncológico, também não possui cobertura pelo rol da ANS – taxatividade mitigada. C) Possibilidade de retirada do medicamento pelo Sistema Único de Saúde. Impugnou ainda o pedido de reembolso e os danos morais.

Decisão de saneamento (págs. 236/239).

Audiência de instrução e julgamento realizada (págs. 247/248), sendo ouvidas as partes e testemunhas e apresentadas alegações finais, vindo os autos conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO:

Cinge-se a controvérsia acerca da obrigatoriedade de cobertura contratual pelo plano de saúde réu de fornecimento da medicação RINVOQ – 15mg (princípio ativo Upadacitinibe) à beneficiária portadora de artrite reumatóide.

Não foram apresentadas preliminares pela parte ré. Assim, tenho que as partes são legítimas, há interesse processual e estão presentes os pressupostos de existência e validade do processo, não havendo vícios a serem sanados, **passando-se de pronto à análise do mérito.**

Durante a audiência de instrução e julgamento a autora**, Maria Fátima Ribeiro Teixeira,** foi ouvida. Informou que tem artrite reumatoide desde 2013/2014. Que é um protocolo médico que primeiro se passa por medicamentos que estão mais baratos, que o próprio paciente pode comprar. Usou vários medicamentos, mas quando chegou uma fase do tratamento a medicação não estava mais segurando os efeitos e começou a sentir muitas dores. Que foi passada essa medicação que é de alto custo. O médico perguntou se ela tinha algum convênio, pois este cobriria, e ela informou que era Unimed.

A autora afirmou ainda que desde então estava fazendo os pedidos do medicamento à Unimed, sendo que houve uma melhora muito grande em sua qualidade de vida. Esse remédio era requerido a cada três meses, e sempre fornecido pela Unimed durante três anos. Informa que antes da interrupção total a Unimed chegou a interromper o fornecimento uma vez, mas retornou com ele. Mas que conforme narra a inicial foi interrompido de vez. Ela disse que não foi informada da motivação da interrupção, e estava ficando sem a medicação. Começou a sentir novamente as dores, e não tinha como conseguir essa medicação, pois não vende regularmente em farmácias. Existe todo um processo para a sua compra. Tentou conseguir a medicação, mas não estava conseguindo, e a ré não estava fornecendo. Informa que as dores que voltou a sentir são em todas as articulações, uma dor muito forte que a impedia até de usar salto. Passou a tomar corticoide e engordou bastante. Até que seu filho conseguiu comprar duas caixas da medicação em São Paulo e então ela

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.

começou a melhorar.

Informa que ficou de quatro a cinco meses sem a medicação, e hoje ela não faz mais o mesmo efeito de antes. O médico disse que pode ter sido em razão da suspensão temporária. Acerca de sua doença disse que ela é uma doença autoimune, com apenas paliativos para que não piore, não traga sequelas. Fala que a interrupção foi bastante grave. O custo atual do medicamento é de R$ 7.200,00 por mês. Atualmente está sendo atendida pelo SUS e o processo para adquirir o medicamento é um pouco trabalhoso, a cada três meses. Tem que passar por médico de novo a cada três meses, fazer baterias de exames.

Às perguntas do advogado da parte ré afirmou que o medicamento que toma é oral. Disse que a evolução da medicina trouxe a possibilidade de tomar o medicamento via oral, mas antigamente era por soro e precisava internar. Confirmou que deu entrada no SUS e que estão fornecendo a ela, e que consta, inclusive, da relação do SUS. Agora faz parte do protocolo do SUS.

Às perguntas de sua advogada esclareceu como foi o procedimento na Unimed quando houve a interrupção do fornecimento da medicação. Disse que eles afirmaram que não iriam fornecer porque não era obrigação do plano. Mas até lá teve muitas dificuldades de receber as informações pela Unimed. Se sentiu desamparada com a negativa do plano de saúde, pois paga um plano caríssimo e quando precisa não é atendida.

Ouvida a preposta da operadora de saúde, sra. **Maria José da Silva Lima**, a qual informou que a negativa se deu conforme o parecer técnico para se tratar de medicamento sem cobertura para uso domiciliar. Não soube informar a razão de a autora ter recebido o medicamento por três anos e depois ter cessado o seu fornecimento.

Às perguntas da advogada da autora, informou que o procedimento adotado para a liberação de medicamentos de alto custo é sempre encaminhar para a auditoria médica para ter um parecer técnico. E aí é finalizado conforme o parecer técnico do médico que analisa, o que é feito por análise documental. Relativamente à suspensão são analisados os documentos já tem contém na empresa.

Disse ainda que normalmente quem comunica a suspensão do fornecimento do medicamento é o prestador, onde o beneficiário vai fazer a utilização do procedimento que foi solicitado. O prestador normalmente é o hospital ou a clínica que solicita. A operadora não tem esse fluxo de informar, não.

Ouvida a informante **Vanessa de Macedo Muniz.** Afirmou ser amiga da autora e a conhece há algum tempo, desde que passaram no concurso. Falou que aproximadamente em 2012 teria ocorrido o primeiro sintoma da autora em relação à doença. Que ela ficou um tempo internada em São Paulo, no hospital. A partir daí que ela começou a ter o diagnóstico e começou a medicações, tendo tomado diversas medicações e até que iam

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.

fazendo efeito, depois parava e até que ela começou a tomar essa medicação que, salvo engano, teria sido um médico de Rondônia que passou para ela. Então ela teve uma melhora significativa tendo ficado mais tranquila.

Afirmou que quando a Unimed parou de fornecer o medicamento a autora ficou um tempo sem a medicação, e começou a inchar as mãos, porque esse era um dos sintomas. Teve que parar a atividade física que fazia, pois não conseguia mais se movimentar. Começou a ter dor nas articulações. Até tomou outras medicações, mas não adiantou.

A ausência do medicamento causou transtornos nela, e o fato dela não conseguir segurar a bolsa dela também, por exemplo, a fazia chorar, por não conseguir segurar também outros objetos. Mencionou todas as dificuldades que a autora teve pela falta do medicamento, e o abalo psicológico pelo qual estava passando.

Em alegações finais orais, a advogada da autora argumentou (conforme consta em áudio e vídeo):

> Após a instrução processual e analisando as provas anexadas aos autos, restou devidamente comprovado que a autora é portadora de grave enfermidade, que foi diagnosticada por laudo médico e cuja prescrição terapêutica demonstra necessidade de uso contínuo de medicamento de alto custo, denominado RINVOG, comprimido esse, medicamento esse, que no mercado tem um valor aproximado de R$ 8 mil.
>
> O laudo médico acostado às folhas 242 dos autos deixou devidamente comprovado que a enfermidade que suporta a autora teve uma melhora considerável apenas quando iniciou o tratamento com referida medicação.
>
> A qual restou comprovado ainda que por um longo período, a mesma usufruiu do referido medicamento, através de um fornecimento da Unimed, plano de saúde da qual integra, desde 2011, salvo engano, conforme o contrato anexado no processo.
>
> Referido medicamento, logrou êxito em estabilizar a doença da autora, e assim, deixá-la segura, acreditando esta estar segura, de que usufruindo do medicamento fornecido pela Unimed, não suportaria mais as dores, nem teria o agravamento de sua doença.
>
> Ocorre que, conforme ratificado pela própria preposta, de forma abrupta e sem qualquer pré-notificação, a Unimed optou por suspender o fornecimento do medicamento.
>
> Deixou explícito ainda a preposta a inexistência de fato gerador, de novo fato gerador, que ensejasse referida à suspensão, pois o tratamento da autora e a doença permaneceram os mesmos desde o início do fornecimento do medicamento, razão pela qual não houve justificativa pela suspensão do fornecimento da medicação.
>
> Referida atitude condicionou a paralisação do tratamento e o agravamento da enfermidade da autora, tendo sofrido um abalo não só em sua saúde física, mas também em sua saúde mental, com prejuízo na sua rotina laboral e social,

Endereço: Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8452, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv5rb@tjac.jus.br - Mod. 500076 - Autos n.º 0713789-81.2024.8.01.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.

conforme informado pelo depoimento desta e ratificado pela sua testemunha, a qual presenciou diversos momentos de sofrimento da autora em decorrência da suspensão do uso do medicamento.

Todavia, os documentos adotados do processo evidenciam de forma inequívoca a imprescindibilidade do medicamento para a manutenção da saúde da autora e o tratamento adequado.

Em que pese ter logrado êxito em usufruir do medicamento através do SUS, referido fornecimento não é seguro para a autora, uma vez que pode ser suspensa a qualquer momento.

Aliás, esta arca mensalmente com o pagamento de um plano de saúde em valores elevados, para que possa usufruir de uma segurança no seu tratamento de saúde.

Deve ser considerado no caso, em comento, o direito fundamental à saúde previsto em nossa Constituição Federal, em seu artigo 196, que também a proteção judicial de tratamentos essenciais.

Ademais, conforme devidamente comprovado no caso, e também o princípio da boa-fé objetiva, referente à autora, que o contrato deve ser interpretado de maneira sistêmica, de modo a evitar a imposição de desvantagem derrazoada à autora, que é conveniada da Unimed, e acreditou estar segura com o tratamento médico fornecido pelo plano de saúde, porém, não teve em contrapartida a prestação de serviços pela qual remunera mensalmente.

A partir dos elementos constantes dos autos, impõe-se reconhecer a obrigação do plano de saúde de arcar com o medicamento pleiteado.

Desta forma, requer a vossa excelência que defira os pedidos constantes da exordial, determinando que a Unimed retorne o fornecimento do medicamento incontinente, bem como que arque com os prejuízos sofridos pela autora, tanto de âmbito material quanto de âmbito moral.É o que requer.

Alegações finais apresentadas pelo advogado da parte ré, Unimed Rio Branco (conforme gravação em áudio e vídeo):

Conforme oportunamente informado, a presente discussão possui afinidade com o informativo 694 do STJ, bem como com o artigo 12, inciso 1, a linha C da lei federal 9656 de 98, que restringe o fornecimento de medicamentos orais apenas para situações excepcionais, como por exemplo para tratamento oncológico, que não se verifica no presente caso.

Sobre a informação da suspensão da disponibilização do medicamento, é preciso observar que nos autos do agravo de instrumento, que foi apreciado pela primeira Câmara do Tribunal de Justiça, as páginas 46 e 49 constam a informação sobre as motivações da ausência de cobertura e demais informações sobre esse questionamento formulado pela requerente, não se tratando, portanto, de suspensão abrupta e imotivada.

Registre-se ainda que o Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo de instrumento, também se debruçou sobre as particularidades do caso e alinhou o seu entendimento conforme o informativo 694 do STJ, reconhecendo a legalidade da ausência de cobertura assistencial do medicamento, pleiteado pela autora na

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.

presente ação por não se tratar das hipóteses excepcionais previstas em lei.

Aliado a isso, conforme depoimento da parte autora e demais elementos probatórios produzidos nos autos nessa fase processual, a referida medicação passou a ser disponibilizada pelo SUS, que conforme a Constituição Federal, possui a obrigação legal de disponibilizar esses medicamentos, por ter a obrigação de disponibilizar o acesso à saúde de forma integral, ao passo que as operadoras atuam de forma complementar a esse sistema, nos termos do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal.

Assim, muito embora tenha ocorrido reflexos na vida cotidiana da parte autora, o fato é que a operadora cumpriu com a sua obrigação legal e contratual dentro dos seus limites, ao passo que fica impugnado os pedidos de indenização por danos morais e materiais pleiteados pela autora na inicial, devendo, no nosso entendimento, e seguindo a tese jurídica tratada desde a defesa preliminar, que seja julgado totalmente improcedente, já que não haverá qualquer prejuízo ao tratamento da autora, uma vez que ela está sendo fornecida com os medicamentos por meio do sistema público, restando somente a questão da indenização por dano moral e material para verificação de eventual ilegalidade praticada pela operadora.

O principal ponto a ser analisado é se há a responsabilidade da parte ré pelo fornecimento do medicamento Rinvoq (princípio ativo Upadacitinibe).

O contrato firmado entre as partes está juntado às págs. 31/50.

Relatório médico juntado às págs. 69, o qual atesta a necessidade de uso do medicamento questionado:

ESPAÇOSAÚDE
Nossa especialidade é cuidar de você!

Dr. Leônidas Tondo
Reumatologista - CRM-RO 3612 | RQE 909
REUMATOLOGIA E DOENÇAS ARTICULARES

Relatório Médico

Sra. Maria Fátima Ribeiro Teixeira acompanha comigo por ser portadora artrite reumatoide desde 2016, quando iniciei a terapêutica com AINH sob demanda, metotrexate 20mg/semana e deflazacort 6mg/diário. Obteve resposta parcial no início do tratamento com piora progressiva.

Então, associado leflunomida 20mg/dia e permaneceu sem resposta, continuando com crises de artrite e dores articulares.

Em agosto de 2021 iniciado Rinvoq 15mg (1 comprimido ao dia) com resposta excelente, desde então, não tendo mais episódios de artrite nem dores articulares.

Não deve sob nenhuma hipótese ficar sem o medicamento Rinvoq porque a doença pode reativar trazendo dores articulares e artrite

Além disso, o receituário médico está juntado à pág. 70.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.

A negativa de cobertura pela parte ré está juntada às págs. 72/74, argumentado no fato de que o referido medicamento serve para tratamento ou aplicação domiciliar, com fundamento no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98.

O réu apresenta duas argumentações para a negativa de fornecimento do medicamento: trata-se de medicamento para uso domiciliar, além de não ser utilizado para tratamento oncológico e não possuir cobertura pelo rol da ANS. E por fim informa que o medicamento pode ser retirado pelo Sistema Único de Saúde.

No que concerne à alegação de que se trata de medicamento para uso domiciliar, isentando a parte ré de fornecimento, temos os seguintes pontos:

Segundo a operadora, estar-se-ia atendendo inclusive a entendimento jurisprudencial, citando o Enunciado n. 117, editado na 6ª Jornada de Saúde do CNJ. Na verdade, este enunciado faz menção ao artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98.

> **Art. 10.** É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
> (...)
> **VI** - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar**, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)

Por outro lado, do que consta dos autos é que o medicamento prescrito à autora (Rinvoq 15mg) é para o uso doméstico.

Apenas medicamento que dependa de internação ou aplicação por profissional, ou quimioterapia, teria cobertura contratual, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. O fármaco foi prescrito para ser administrado em ambiente externo ao de unidade de saúde, tal como tantos outros analgésicos, todos sem cobertura por plano de saúde. De acordo com o Parecer Técnico nº 20 da ANS[1], o fornecimento desses medicamentos não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias, em atenção ao artigo 17, alínea C, inciso VI da Resolução Normativa nº 465 de 2021:

> Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o planoreferência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e

[1] https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_20_2021_medicamentos_para_tratamento_domiciliar.pdf

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.

> emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

Ressalte-se o Informativo nº 694 do STJ, de 3/05/2021 que destacou o entendimento aplicadoREsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/04/2021, com o seguinte teor: É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (*home care*) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim.

Nesse sentido:

> APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. UPADACITINIBE. AUSÊNCIA DE DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA .
> - A controvérsia objeto da lide - dever (ou não) de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento ou procedimento indicado pelo médico assistente - encontrava amplo espaço para divergência jurisprudencial em todos os âmbitos do Poder Judiciário, o que também refletia nos julgados proferidos pelo STJ. Entretanto, em recente julgado, a Seção competente ao julgamento da matéria, compreendida pela Terceira e Quarta Turmas do Tribunal da Cidadania, fixou teses sobre a a matéria, dentre outras, indicando que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pode ser relativizado.
> - A Lei n.º 9 .656/98 (Lei dos Planos de Saúde - LPS), em seu art. 10, VI, prevê a exclusão de cobertura dos medicamentos de uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos. Portanto, por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não antineoplásico, não há dever de cobertura pelo plano de saúde.
> - Não há dever de cobertura do medicamento Upadacitinibe pelo plano de saúde, pelo que deve ser provido o recurso de apelação para julgar improcedente a demanda . Ônus sucumbenciais invertidos.APELO PROVIDO. UNÂNIME.
> (Apelação Cível, Nº 50590856120238210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 25-04-2024)

Pelas razões acima, não deve prosperar o pedido de indenização por danos materiais, bem como a obrigação de fazer, concernente ao fornecimento do medicamento exposto na inicial. E também em razão da aludida improcedência, deixo de analisar o fato de a autora estar no atual momento sendo atendida pelo SUS.

No entanto, no que concerne ao pedido de **indenização por danos**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.

morais, em que pese a improcedência acima explicada, aquele deve prosperar.

O fundamento trazido pela autora não é somente a negativa no fornecimento de medicamento. Afirma ela que a ré vinha fornecendo o medicamento e sem qualquer aviso prévio negou-se a continuar o fornecimento.

Ocorre que a autora já estava fazendo um tratamento médico, utilizando o medicamento fornecido pela ré. A interrupção sem possibilitar prazo suficiente à autora para procurar outros meios para adquirir, trouxeram a ela graves prejuízos. Conforme afirmou em audiência sua situação ficou mais debilitada, pois as dores retornaram. E mesmo agora que está fazendo uso do medicamento fornecido pelo SUS, não está mais como antes, pois tem sequelas da interrupção do tratamento.

Veja-se que na própria a inicial a autora afirmou que:

> Referida decisão carreada de quebra de expectativa levou a Demandante a ficar sem o medicamento, o qual é de difícil aquisição, precisando compra-lo em uma farmácia situada no interior do estado de Goiás, pelo valor R$ 7.198,03 (sete mil cento e noventa e oito reais e três centavos), ocasionando a demora no recebimento e a suspensão do tratamento.
>
> Ocorre que referida negativa além de abalar o orçamento mensal da Demandante, que teve que despender valores consideráveis para adquirir o medicamento, ocasionou um declive em sua condição física pois foi compelida a ficar na abstinência do medicamento por diversos dias até o recebimento do mesmo.

Veja-se que, mesmo tendo ocorrido a notificação, esta se deu quando a autora buscou o medicamento, como ocorria de costume. No entanto, sendo informada de que não mais o receberia, a autora, que reside no Estado do Acre, teve que buscar meios de adquiri-lo, o que somente ocorreu em outro Estado, deixando-a sem o medicamento por diversos dias.

O abalo físico e emocional foram comprovados, sendo razoável a quantia de R$ 8000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

DISPOSITIVO:

Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face da ré UNIMED RIO BRANCO, resolvendo o mérito da ação, nos moldes do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

A) Julgo **improcedente** o pedido de condenação na obrigação de fazer, consistente na entrega do medicamento Rinvoq 15mg, bem como o pedido de indenização por danos materiais.

B) Julgo **procedente** o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da presente data, conforme Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça, além de serem devidos juros de mora pela Selic, a partir da citação, consoante artigo 405, do Código Civil, devendo ser deduzido do cálculo o IPCA quando aplicada a taxa Selic.

Diante da sucumbência recíproca, ficam as partes condenadas ao pagamento de custas processuais, no percentual de 50% para cada uma, bem como honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, a ser pago pela parte ao advogado da parte adversa.

Publique-se. Intimem-se.

Ao final, em não havendo outras solicitações, arquivem-se.

Rio Branco-(AC), 15 de agosto de 2025.

Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito

Endereço: Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8452, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv5rb@tjac.jus.br - Mod. 500076 - Autos n.º 0713789-81.2024.8.01.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SHIRLEI DE OLIVEIRA HAGE MENEZES, liberado nos autos em 17/08/2025 às 08:23 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0713789-81.2024.8.01.0001 e código 49NfzAJG.